

Guía de Escalas e Instrumentos de Evaluación

Tipos de evaluación y selección

TIPOS DE EVALUACION: DIFERENCIAS CLAVE

ADMINISTRADAS POR EL PROFESIONAL	AUTOEVALUACIONES (autoinforme del paciente)
· Quien la toma: el profesional en sesión	· Quien la completa: el paciente, de forma autónoma
· Formato: entrevista estructurada o semiestructurada	· Formato: cuestionario de respuesta múltiple (Likert)
· Ejemplos: SCID-5, MINI, CAPS-5, DIVA 2.0	· Ejemplos: PHQ-9, GAD-7, BDI-II, BAI, PCL-5
· Cuando usarlas: evaluación inicial, diagnóstico diferencial, investigación clínica profunda o evaluación de alta	· Cuando usarlas: línea de base, monitoreo continuo, seguimiento de síntomas entre sesiones
· Ventaja: mayor precisión diagnóstica y contextual	· Ventaja: bajo costo, rápidas, permiten ver tendencias

ESCALAS SEGUN TRASTORNO O MOTIVO DE CONSULTA

Trastorno / Motivo	Autoevaluación (paciente)	Administrada por profesional	Observación
Depresión	PHQ-9, BDI-II	HAMD-17, MADRS, SCID-5	PHQ-9: 9 ítems, rápida y validada
Ansiedad generalizada	GAD-7, BAI	HAMA, SCID-5	GAD-7: 7 ítems, punto de corte: 10
Ansiedad social	SPIN, LSAS-SR	LSAS (clínico)	SPIN: 17 ítems, screening rápido
Pánico / Agorafobia	PDSS-SR, ACQ	PDSS, ADIS-5	PDSS-SR: autoinforme de PDSS
TEPT (trauma)	PCL-5, IES-R	CAPS-5	PCL-5: 20 ítems, criterios DSM-5
TOC	OCI-R, Y-BOCS SR	Y-BOCS (clínico)	OCI-R: 18 ítems, 6 subescalas
Riesgo / Suicidio	C-SSRS SR, SBQ-R	C-SSRS (clínico)	SIEMPRE combinar con eval. clínica
TDAH adultos	ASRS, CAARS-S	DIVA 2.0, CAARS observer	ASRS: 6 ítems de tamiz
Disociación	DES-II	MID, SCID-D	DES > 30: seguir con MID
TCA	EDE-Q, EAT-26	EDE (clínico)	EDE-Q: gold standard en TCA
Adicciones / Alcohol	AUDIT, CAGE	ASSIST, MINI módulo sust.	AUDIT-C: versión de 3 ítems

CLAVE CLÍNICA

- Las autoevaluaciones NO reemplazan el juicio clínico. Son herramientas de monitoreo y apoyo diagnóstico.
- Ante riesgo de suicidio o autolesiones: usar evaluación administrada por el profesional como primer recurso.
- El puntaje de corte es una guía orientadora; siempre interpretar en contexto clínico.

Guía de Escalas e Instrumentos de Evaluación

Selección según población y momento del tratamiento

ESCALAS SEGUN POBLACION

NINOS (6-12 AÑOS)	ADOLESCENTES (13-17 AÑOS)	ADULTOS MAYORES (60+)
· CDI-2: Depresión infantil (Beck)	· PHQ-A: Depresión (versión adolesc.)	· GDS-15: Depresión geriátrica
· SCARED: Ansiedad (niños y padres)	· RCADS: Ansiedad y depresión	· GAI: Ansiedad geriátrica
· CPRS-R: Conducta (Conners, padres)	· BDI-II: Válido desde 13 años	· MMSE / MoCA: Cribado cognitivo
· CTRS-R: Conducta (Conners, docentes)	· BAI: Válido desde 13 años	· PHQ-9: Válido en esta población
· CMAS-R: Ansiedad manifiesta	· SCARED: Ansiedad	· CSDD: Depresión en demencia
· MASC-2: Ansiedad multidimensional	· C-SSRS SR: Riesgo suicida	· EPDS: Para postparto en mayores
<i>Nota: incluir siempre versión para padres</i>	<i>Nota: validar comprensión lectora</i>	<i>Nota: evaluar deterioro cognitivo previo</i>
<i>Nota: adaptar lenguaje y verificar comprensión</i>	<i>Nota: explorar contexto escolar y vincular</i>	<i>Nota: considerar nivel de lectura</i>

CONTEXTOS ESPECIALES Y POBLACIONES ESPECIFICAS

Contexto	Instrumentos sugeridos	Observación clave
Perinatal / Postparto	EPDS (Edinburgh): gold standard postparto. PHQ-9 como alternativa. Administrar semanas 6-8 post parto.	EPDS: 10 ítems, validado en español rioplatense
Pareja / Relación	DAS-7 (ajuste diádico), RAS (satisfacción relacional), CTS-2 (conflicto y violencia)	CTS-2: screening de violencia en la pareja
Duelo complicado	PG-13 (Prolonged Grief), BGQ (Brief Grief Questionnaire)	PG-13: criterios DSM-5-TR y CIE-11
Psicosis / Espectro	PANSS (administrada), BASIS-24, SRS	PANSS: requiere entrenamiento específico previo
Trauma complejo	DES-II: screening. MID: diagnóstico. IES-R: impacto del evento.	DES-II > 30: continuar con MID completo

CUANDO USAR CADA TIPO SEGUN EL MOMENTO DEL TRATAMIENTO

Momento	Que hacer	Herramientas sugeridas
Evaluación inicial	Autoevaluaciones de línea de base + entrevista diagnóstica completa. Establece el punto de partida para medir cambio a lo largo del proceso.	PHQ-9, GAD-7 según motivo + MINI o SCID-5
Sesiones de seguimiento	Autoevaluaciones rápidas cada 4-8 sesiones. Monitoreo de síntomas, detección temprana de recaídas o estancamiento.	Mismas escalas de la línea de base
Revisión de objetivos	Re-administrar instrumentos iniciales para medir cambio. Comparar con puntaje de inicio para evaluar eficacia del tratamiento.	Todas las escalas del inicio
Evaluación de alta	Evaluación completa final. Los puntajes de cierre quedan en el informe y sirven de referencia para seguimiento post-alta.	Completo: autoevaluación + entrevista clínica

CLAVE CLINICA

- Niños: siempre incluir versión para padres/cuidadores además de la auto-administrada.
- Adultos mayores: evaluar nivel de lectura y deterioro cognitivo antes de administrar autoinformes.
- El puntaje de corte es una guía, no un diagnóstico. El juicio clínico contextualizado es siempre prioritario.

Guía de Escalas e Instrumentos de Evaluación

Referencia rápida: descripción, ítems y puntos de corte

AUTOEVALUACIONES: DESCRIPCIÓN, ÍTEMS Y PUNTOS DE CORTE

Escala	Área clínica	Ítems	Rango	Puntos de corte / Interpretación	Observaciones
PHQ-9	Depresión	9	0-27	0-4: Min 5-9: Leve 10-14: Mod 15-19: Mod-Sev 20+: Severo	Válido desde 13 años. Perinatal: EPDS.
GAD-7	Ansiedad generalizada	7	0-21	0-4: Min 5-9: Leve 10-14: Mod 15+: Severo	Punto de corte clínico: 10. Sensible para otras ansiedades.
BAI	Ansiedad (Beck)	21	0-63	0-7: Min 8-15: Leve 16-25: Mod 26+: Severo	Enfocado en síntomas somáticos. Útil en trastorno de pánico.
BDI-II	Depresión (Beck)	21	0-63	0-13: Min 14-19: Leve 20-28: Mod 29+: Severo	Desde 13 años. Ítem 9 evalúa ideación suicida.
PCL-5	TEPT	20	0-80	Punto de corte sugerido: ≥ 33 (probable TEPT)	Basado en criterios DSM-5. No usar como único criterio.
OCI-R	TOC	18	0-72	Punto de corte: ≥ 21 probable TOC	6 subescalas: lavado, verificación, neutralización, orden, obsesión, acumulación.
SPIN	Ansiedad social	17	0-68	Punto de corte: ≥ 19 probable fobia social	Screening rápido y sensible para ansiedad social.
EDE-Q	TCA	28	0-6	Punto de corte global: ≥ 2.3 (probable TCA)	Gold standard en autoinformes de conducta alimentaria.
AUDIT	Consumo de alcohol	10	0-40	0-7: Bajo riesgo 8-15: Riesgo 16-19: Perjudicial 20+: Dep.	AUDIT-C (ítems 1-3): versión ultra-breve de screening.
EPDS	Depresión perinatal	10	0-30	≥ 13 postparto / ≥ 10 embarazo	Validado en español rioplatense. Ítem 10: ideación suicida.
C-SSRS SR	Riesgo suicida	Var	0-5	Cualquier puntaje ≥ 1 requiere evaluación clínica inmediata	Siempre combinar con entrevista directa del profesional.
GDS-15	Depresión geriátrica	15	0-15	0-4: Normal 5-8: Leve 9-11: Mod 12+: Severo	Versión corta del GDS-30. Adaptada para adultos mayores.
DES-II	Disociación	28	0-100	Punto de corte: ≥ 30 (pesquisa de disociación)	Screening. Puntaje > 30 : aplicar MID o SCID-D completo.
ASRS	TDAH adultos	6	0-24	Punto de corte: ≥ 14 (probable TDAH adulto)	Tamiz inicial. Ítems 1-6 de la escala completa ASRS v1.1.

CLAVE CLÍNICA

- Esta guía es un recurso de referencia clínica. Los puntos de corte pueden variar según versión, población y contexto.
- Escalas con validación en Argentina: PHQ-9, GAD-7, BAI, BDI-II, EPDS, AUDIT, OCI-R. Verificar la versión utilizada.
- Fuentes: APA (DSM-5-TR 2022), OPS, Ministerio de Salud Argentina, validaciones en revistas indexadas (2015-2024).